



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

ETIKA DAN HUKUM DALAM REKAM MEDIS

Silvia Intan Wardani • Siti Nur Umariyah Febriyanti • Rizka Dwiyo Vita
Hastin Atas Asih

Editor: Irma HY Siregar



BUNGA RAMPAI: ETIKA DAN HUKUM DALAM REKAM MEDIS

Penulis:

Dr. Silvia Intan Wardani, S.Tr.Keb., M.Kes.
Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.
Rizka Dwiyoita, S.K.M., M.K.M.
Hastin Atas Asih, S.KM., M.Kes.

Editor:

drg. Irma HY Siregar, MH.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Etika Dan Hukum Dalam Rekam Medis

Penulis: Dr. Silvia Intan Wardani, S.Tr.Keb., M.Kes.

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

Rizka Dwiyo Vita, S.K.M., M.K.M.

Hastin Atas Asih, S.K.M., M.Kes.

Editor: drg. Irma HY Siregar, MH.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-19-0

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Bunga Rampai: Etika dan Hukum dalam Rekam Medis* ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya wawasan dan pemahaman para tenaga kesehatan, akademisi, maupun masyarakat umum mengenai pentingnya aspek etika dan hukum dalam pengelolaan rekam medis.

Rekam medis bukan hanya sekadar kumpulan data medis pasien, melainkan dokumen penting yang memiliki nilai etik, hukum, dan profesional yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam buku ini, disajikan empat pokok bahasan utama. Pertama, *Etika dalam Penyimpanan dan Penggunaan Rekam Medis*, yang mengulas prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien. Kedua, *Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis*, yang menjelaskan konsekuensi yuridis dari pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi medis. Ketiga, *Hak Akses Pasien terhadap Rekam Medis*, yang menegaskan posisi pasien sebagai pemilik informasi dan haknya untuk mengetahui isi rekam medis secara transparan. Keempat, *Tantangan Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis*, yang

membahas isu-isu kontemporer seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data kesehatan.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 ETIKA DALAM PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN REKAM MEDIS1

Dr. Silvia Intan Wardani, S.Tr.Keb., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Aspek Etika Rekam Medis.....	3
C. Etika Profesi Perkam Medis	4
D. Kesimpulan.....	5
E. Referensi.....	6

CHAPTER 2 IMPLIKASI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS9

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.....	9
A. Pendahuluan.....	9
B. Rekam Medis dan Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien	10
C. Hak Pasien atas Informasi dalam Rekam Medis	23
D. Dasar Hukum Rekam Medis	24
E. Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis.....	28
F. Simpulan	38
G. Referensi.....	39

CHAPTER 3 HAK AKSES PASIEN TERHADAP

REKAM MEDIS 41

Rizka Dwiyovita, S.K.M., M.K.M.....	41
A. Pendahuluan/Prolog.....	41
B. Definisi Rekam Medis.....	43
C. Dasar Hukum Hak Akses Pasien Terhadap Rekam Medis.....	46
D. Sumber-Sumber Hukum Internasional yang berhubungan dengan Hak Akses Pasien	47
E. Hak Pasien dalam Mengakses Rekam Medis	58
F. Kepemilikan Rekam Medis	59
G. Tantangan dalam Mengakses Rekam Medis oleh Pasien	63
H. Simpulan	65
I. Referensi.....	66
J. Glosarium.....	67

CHAPTER 4 TANTANGAN ETIKA DALAM ERA

DIGITALISASI REKAM MEDIS 69

Hastin Atas Asih, S.KM., M.Kes.	69
A. Pendahuluan/Prolog.....	69
B. Masalah-masalah Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis.....	72
C. Program Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis ...	78
D. Hambatan Program Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis.....	80
E. Implementasi Digitalisasi Rekam Medis di Berbagai Negara	82
F. Perspektif Masa Depan Digitalisasi Rekam Medis	84
G. Rekomendasi Strategis	85

H. Simpulan	86
I. Referensi.....	87
J. Glosarium.....	90

PROFIL PENULIS	91
-----------------------------	-----------

CHAPTER 1

ETIKA DALAM PENYIMPANAN DAN PENGUNAAN REKAM MEDIS

Dr. Silvia Intan Wardani, S.Tr.Keb., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat sehingga dapat mencapai kesehatan yang optimal sebagai komponen kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia, 1945), selain itu untuk mendukung pembangunan kesehatan yang baik didukung dengan adanya rekam medis di lingkungan kesehatan.

Rekam medis merupakan suatu catatan atau berkas yang berisikan suatu catatan maupun dokumen terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, kegiatan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Pengumpulan data riwayat medis berlangsung sejak pasien masuk dari rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit dengan melakukan segala macam tindakan maupun pengobatan yang diberikan (Kemenkes RI, 2008).

Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih menurut semua bidang tidak terkecuali bidang kesehatan dalam meningkatkan dan mempersiapkan

kualitas tenaga kesehatannya, sehingga mampu bersaing secara global dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan, efektif, efisien serta berkualitas bagi masyarakat. Profesi rekam medis merupakan salah satu profesi dalam bidang pelayanan kesehatan di Rumah sakit, dinas kesehatan, asuransi kesehatan, institusi pendidikan dan pelayanan terkait lainnya, dimana mereka berperan secara profesional dalam aspek administrasi, mengelola berkas-berkas dokumen penting pada pasien yaitu berupa catatan identitas pasien, hasil pemeriksaan yang dijalani, pengobatan yang diterima, tindakan hingga pelayanan apa saja yang telah diberikan kepada pasien; sebagai sumber informasi baik dari sisi aspek hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, pendokumentasian dan kesehatan masyarakat.

B. Aspek Etika Rekam Medis

Berdasarkan Permenkes 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto, radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik.

Beberapa poin penting terkait dengan Aspek Etika

1. Kerahasiaan dan Privasi:

- a. Etika Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan informasi pasien merupakan kewajiban etis bagi semua tenaga kesehatan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat merusak kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan.
- b. Privasi Pasien: Data medis pasien adalah hak pribadi yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak etis.

2. Transparansi dan Persetujuan:

- a. Informed Consent: Pasien harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan harus memberikan persetujuan sebelum data tersebut dikumpulkan atau dibagikan.

- b. **Transparansi Penggunaan Data:** Fasyankes harus transparan dalam penggunaan data pasien, termasuk untuk tujuan penelitian atau pengembangan layanan kesehatan.

3. Keamanan Data:

- a. **Perlindungan Terhadap Ancaman:** Fasyankes memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi data pasien dari ancaman keamanan seperti peretasan atau malware.
- b. **Peningkatan Keamanan:** Secara etis, fasyankes harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pasien.

4. Keadilan dan Aksesibilitas:

- a. **Akses yang Adil:** Semua pasien harus mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan dan teknologi RME, tanpa diskriminasi.
- b. **Etika Keadilan:** Dalam penggunaan RME, harus dipastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek hukum dan etika ini, fasyankes dapat memastikan bahwa pengelolaan rekam medis elektronik dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang berlaku.

C. Etika Profesi Perkam Medis

Rekam Medis dapat diartikan sebagai berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

diberikan kepada pasien. Pengumpulan data rekam medis dilakukan mulai pasien diterima hingga keluar dari rumah sakit dengan segala macam tindakan maupun pengobatan yang diberikan. Profesi yang mengolah data rekam medis itu disebut petugas rekam medis atau staf ahli informasi medis. Rekam medis sebagai bentuk dari pendokumentasian layanan kesehatan telah ada dan berkembang bersama dengan praktek layanan kesehatan. Namun demikian bahwa tidak setiap catatan adalah rekam medis. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang telah merambah bidang pelayanan kesehatan menjadikan bentuk rekam medis menjadi sangat beragam sehingga dikenal istilah rekam medis multimedia (*multimedia medical record*). Dalam perkembangannya sebagai suatu profesi perekam medis akhirnya berkembang tidak hanya sebagai pengelola berkas saja tetapi lebih luas sebagai pengelola informasi kesehatan baik secara manual maupun elektronik. Sebagai profesional di bidang rekam medis dan informasi kesehatan memiliki organisasi profesi yang mewadahi aspirasi dan arah perkembangan profesi ini yaitu PORMIKI (Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi kesehatan Indonesia).

D. Kesimpulan

Rekam medis menjembatani pemberian informasi antara dokter, pasien dan rumah sakit. Dari aspek etika dan hukum rekam medis selain tantangan integrasi dan data klinis dan genomik, tantangan dalam implementasi

penggunaan rekam medis baik manual dan elektronik dalam era *personalizer medicine* adalah tantangan etika dan hukum, terdapat beberapa isu etika dan hukum seperti permasalahan privasi dan kepemilikan data pasien, diskriminasi genomik, pergeseran hubungan dokter dan pasien, serta permasalahan mengenai tanggung jawab hukum.

Privasi merupakan suatu kondisi yang membatasi akses terhadap informasi seseorang salah satunya informasi mengenai kesehatan seseorang. Privasi berhubungan dengan konfidensialitas yang merupakan keadaan untuk menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan informasi ke orang lain tanpa persetujuan pemilik data. hal yang penting dalam privasi adalah keamanan data sehingga tidak terjadi kebocoran data ke pihak lain. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2008).

E. Referensi

- Depkes RI. (2006), Pedoman penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia., Jakarta: Depkes RI
- Desrizza Ratman, (2019), Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik, Bandung : Keni Media

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Media.

Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 01.07/Menkes/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Medical Records Manual: A Guide for Developing Countries. (2002). Phipippines: World Health Organization

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerja Perekam Medis

Permenkes Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Rekam Medis

Permenkes Nomor 269/ PER/MENKES/III/2008 Tentang Rekam Medis

CHAPTER 2

IMPLIKASI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

A. Pendahuluan

Rekam medis merupakan dokumen penting yang memuat informasi pribadi, riwayat kesehatan, diagnosis, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis yang diberikan kepada seorang pasien. Informasi dalam rekam medis bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum, mengingat sifatnya yang sangat pribadi dan potensial menimbulkan dampak serius apabila disalahgunakan atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis bukan hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi pasien, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi pelaku, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, maupun administrasi.

Di Indonesia, perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis telah diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan masih kerap terjadi, baik karena kelalaian, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun lemahnya sistem perlindungan data medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi hukum akibat pelanggaran kerahasiaan rekam medis menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum yang dapat timbul, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem perlindungan data medis di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis secara lebih efektif.

B. Rekam Medis dan Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien

Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data rekam medis. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the*

right to choose) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). (Zulham 2013)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis mengharuskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Pasal 2 Permenkes ini disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan Rekam Medis mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Rekam Medis; menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

Penyimpanan RME harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data RME seperti tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam RME terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan rekam medis wajib:

1. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh tindakan yang dilakukan secara lengkap dan jelas;

2. Menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis;
3. Menjamin perlindungan data dan informasi rekam medis Pasien;
4. Memastikan kesesuaian sistem elektronik yang kompatibel antara satu sistem dengan sistem elektronik lainnya sesuai dengan variabel dan meta data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
5. Memastikan sistem elektronik yang berbeda mampu bekerja secara terpadu melakukan komunikasi menggunakan standar pertukaran data. (PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2024)

Pasal 29 Permenkes tersebut dinyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan; integritas; dan ketersediaan. Kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022)

Dokumen rekam medis merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menjaga

keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. (PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2024). Berikut beberapa definisi rekam medis yaitu:

1. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. (UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2023)
2. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022)
3. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022)

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal

173 ayat (1) huruf c, tak terkecuali rumah sakit sesuai Pasal 189 ayat (1) huruf h dan Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, ditambahkan juga dalam Pasal 833 dan 840 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan rekam medis" adalah penyelenggaraan rekam medis yang dilakukan sesuai dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai standar internasional.

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi harus menggunakan rekam medis elektronik dan mempunyai standar interoperabilitas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, tersebut dalam Pasal 552 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Menurut pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, bahwa isi rekam medis milik pasien dan dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain. Isi rekam medis paling sedikit terdiri atas :

1. Identitas pasien
2. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
3. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan
4. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Hak menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan,

standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam hal Pasien meminta:

1. Melakukan aborsi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Bunuh diri dengan bantuan;
3. Mencarikan ibu pengganti atau sewa rahim hasil reproduksi dengan bantuan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah;
4. Memberikan keterangan palsu;
5. Melakukan perbuatan curang; dan/atau
6. Tindakan lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak tersebut dilakukan setelah Pasien diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut dan dicatat dalam dokumen tertulis berupa rekam medis atau dokumen tertulis lain. Pasal 777 ditegaskan kembali bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis.

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis terdiri dari :

1. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya
2. Puskesmas
3. Klinik

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

4. Rumah Sakit
5. Apotek
6. Laboratorium kesehatan
7. Balai dan
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 165 ayat (2) meliputi:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; dan
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.

Pada Pasal 30 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan hak akses kepada tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak akses terdiri atas hak untuk penginputan data, perbaikan data, dan melihat data. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022) Selain pemberian hak akses, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan RME dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentifikasi atas isi rekam medis elektronik dan identitas penanda tangan. (Wahyuntara 2024)

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis, ketentuan tersebut ditekankan di Pasal 296 ayat (1) UU Kesehatan. Ditambahkan juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 778 setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien, termasuk persetujuan tindakan Pelayanan Kesehatan. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut juga di UU Kesehatan Pasal 296 ayat (5). Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam

medis. Begitu juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 735 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien. Yang dimaksud dengan "rahasia kesehatan pribadi pasien" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien serta bersifat rahasia.

Pasal 788 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ditegaskan kembali bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi Pasien. Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi Pasien. Rahasia kesehatan pribadi pasien terdiri atas :

1. Identitas Pasien;
2. Data dan Informasi kesehatan Pasien yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan pelayanan kesehatan; dan
3. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Rahasia kesehatan pribadi pasien merupakan bagian dari rekam medis. Semua pihak pada Fasilitas Pelayanan

Kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien, pihak tersebut meliputi :

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
2. Pimpinan dan manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan Pelayanan Kesehatan;
4. Tenaga lainnya yang memiliki data dan Informasi Kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
5. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2024)

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi Pasien. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 301 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Isi Rekam Medis juga wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Pihak yang dimaksud meliputi:

1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

4. Badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
6. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Di dalam penyelenggaraan RME, Menteri memfasilitasi penyediaan sistem elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pada penyelenggaraan RME dapat dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri atau penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerjasama. Penyelenggaraan RME yang menggunakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara RME wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari nama sistem elektronik; dokumentasi sistem; fitur/fungsi yang tersedia; lokasi penyimpanan data; variable dan metadata; dan daftar fasilitas pelayanan kesehatan pengguna sistem elektronik, Apabila ada perubahan data harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.

Ada beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang berkaitan dengan kerahasiaan medis, antara lain:

1. Pasal 12 : menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik wajib memperhatikan kerahasiaan informasi medis pasien.
2. Pasal 13 : menyebutkan bahwa akses terhadap Rekam Medis Elektronik hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang berwenang, yang terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien, serta pihak yang memiliki kewenangan hukum.
3. Pasal 14 : menyebutkan bahwa penyelenggara Rekam Medis Elektronik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien.
4. Pasal 15 : mengatur bahwa setiap orang yang memiliki akses terhadap Rekam Medis Elektronik berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya.
5. Pasal 16 : menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Rekam Medis Elektronik harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur kerahasiaan informasi medis, termasuk dalam hal manajemen akses, penyimpanan, dan penggunaan informasi medis.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki peran penting dalam menjaga privasi dan keamanan informasi kesehatan pasien, termasuk rekam medis. Dengan tujuan untuk menetapkan

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

persyaratan pengumpulan data pribadi pasien, termasuk rekam medis, serta batasan-batasan untuk penggunaan data tersebut. Hal ini memastikan bahwa data pribadi hanya dikumpulkan dan digunakan sesuai dengan kepentingan pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini : a. Yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. Di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1) Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2) Bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa ada beberapa asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, yaitu : a. Pelindungan; b. Kepastian hukum; c. Kepentingan umum; d. Kemanfaatan; e. Kehati-hatian; f. Keseimbangan; g. Pertanggungjawaban; h. Kerahasiaan. Undang-Undang ini memberikan pedoman tentang tindakan yang harus diambil untuk melindungi data pribadi pasien, termasuk rekam medis dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup kebijakan keamanan teknis dan administratif yang harus diimplementasikan oleh penyedia pelayanan fasilitas kesehatan untuk mencegah insiden pelanggaran data. Pada pasal 33 menyebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada subjek data pribadi dalam hal : a.

Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; b. Berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

C. Hak Pasien atas Informasi dalam Rekam Medis

Salah satu hak pasien adalah mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis seperti tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 276 huruf e dan Pasal 297 ayat (2). Akses informasi terhadap dokumen rekam medis, antara lain berupa rekam medis atau penjelasan lisan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Hak pasien untuk mendapat akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis tercantum juga dalam Pasal 737 ayat (1) huruf e dan ayat (8) PP Nomor 28/2024, informasi tersebut meliputi :

1. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
2. Diagnosis, pengobatan, tindakan, dan prognosis; dan
3. Pelayanan lain yang diberikan kepada Pasien.

Pasien bisa menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap dan memadai serta dicatat dalam rekam medis.

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

Dokumen Rekam Medis milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan, kehilangan, pemalsuan dan / atau penggunaan oleh orang dan /atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Isi rekam medis disampaikan kepada pasien. Dalam hal pasien dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan / atau pasien dalam keadaan darurat isi rekam medis bisa disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pasien.

D. Dasar Hukum Rekam Medis

Di Indonesia, saat ini rekam medis diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Peraturan tersebut terdiri atas empat bab, diantaranya menjelaskan tentang ketentuan umum, penyelenggaraan rekam medis, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan penutup. Perkembangan pengaturan rekam medis dan kerahasiaannya di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 28 Huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
2. Pasal 28 Huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
4. Kepmenkes RI No. 031/Birhup/1972, dalam keputusan tersebut rumah sakit diharuskan melakukan *medical recording, reporting* dan *hospital statistic*.
5. Kepmenkes RI No. 034/Birhup/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, dalam keputusan tersebut tercantum ketentuan bahwa untuk menunjang Rencana Induk (*Master Plan*) yang baik maka setiap rumah sakit diwajibkan memiliki dan selalu memperbarui statistik serta membina *medical record* berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kepmenkes RI No. 134/Menkes/SK/IV/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum, dalam ketentuan tersebut diinformasikan bahwa sub bagian pencatatan medis memiliki tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis.
7. Fatwa IDI tentang Rekam Medis (SK No. 315/PB/A.4/88- 8 Februari 1988) Peraturan tersebut menekankan bahwa praktik profesi kedokteran harus melaksanakan rekam medis. Dalam hal ini, beberapa persoalan rekam medis juga harus diketahui tenaga kesehatan.

8. SK Menteri Kesehatan No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (Medical Record), dalam SK tersebut tersurat adanya kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan rekam medis.
9. Pasal 322 KUHP
 - a. *"Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.9000,-."*
 - b. *"Jika kejahatan ini dilakukan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu".* (Noviriska & Dwi Atmoko 2022)
10. Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1367 KUHPerdata : *"Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu."*
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
14. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
15. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
17. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

Beberapa ketentuan pembukaan isi rekam medis tercantum dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tercantum dalam Pasal 33-38. Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan pasien; dan/atau tidak atas persetujuan pasien. Permintaan pembukaan isi Rekam Medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik dan dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pasal 34 (1) disebutkan bahwa pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:

1. Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
2. Permintaan Pasien sendiri; dan/atau
3. Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.

Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:

1. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. Penegakan etik atau disiplin;
3. Audit medis;
4. Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana;
5. Pendidikan dan penelitian;
6. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau
7. Lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembukaan isi Rekam Medis dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3).

Pasal 735 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa rahasia kesehatan pasien dapat dilakukan pembukaan untuk kepentingan:

1. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. Penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
3. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;

5. Kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
6. Permintaan Pasien sendiri;
7. Kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau
8. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 783 disebutkan bahwa pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan atas persetujuan Pasien; dan/atau tidak atas persetujuan Pasien. Permintaan pembukaan isi rekam medis harus dilakukah secara tertulis, secara elektronik atau nonelektronik. Pembukaan isi rekam medis dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan:

1. Pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
2. Permintaan Pasien sendiri; dan/atau
3. Administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan.

Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi rekam medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat meliputi suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung pasien atau pengampunya atau oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum,

meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan tidak diperlukan. Pembukaan isi rekam medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan harus dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik melalui persetujuan umum pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pembukaan isi rekam medis tidak atas persetujuan pasien dilakukan untuk kepentingan:

1. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. Penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
3. Pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan
5. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permintaan pembukaan isi rekam medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 36 ayat (1) sampai (4) disebutkan bahwa pembukaan isi rekam medis harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, yaitu pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Berdasarkan persetujuan Menteri maka pihak atau institusi yang berwenang menyampaikan permintaan pembukaan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Persetujuan

dari Menteri dikecualikan untuk pembukaan isi Rekam Medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan/atau memperlihatkan dokumen asli. Pengecualian tersebut antara lain penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana; dan upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022)

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 177 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien. Undang-Undang ini menetapkan standar yang harus dipatuhi dalam pengelolaan data pribadi pasien yang mencakup keamanan informasi, pengaturan akses terhadap data medis, dan kewajiban menjaga kerahasiaan oleh pihak terkait seperti tenaga medis dan lembaga kesehatan. Aturan tersebut terdapat pada pasal 351 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan setiap individu. (2) Pemrosesan data dan informasi kesehatan yang menggunakan data kesehatan individu wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan/atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan

data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (4) bahwa kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:

1. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. Penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
3. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
5. Kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
6. Permintaan Pasien sendiri;
7. Kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau
8. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasien dan/atau keluarga pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum, yang mana

berkenaan dengan hal tersebut memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penyimpanan data RME di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien. Setelah batas waktu berakhir, data RME dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan dan prosedur pemusnahan RME dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis dalam perlindungan hak atas rahasia medis pasien adalah faktor sosial yang meliputi seluruh civitas hospitalia yang terdiri dari kepala rumah sakit, wakil kepala rumah sakit, jajaran pimpinan rumah sakit dan seluruh pegawai rumah sakit maupun pasien dan keluarganya adalah masyarakat, di mana dengan komposisi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang beragam, ada yang kesadaran hukumnya sudah tinggi sampai yang kesadaran hukumnya masih rendah akan berdampak pada keberhasilan implementasi Permenkes tersebut kaitannya dalam perlindungan hak atas rahasia medis pasien. (Wahyuntara 2024)

Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi atau kebocoran data medis elektronik yang merugikan hak-hak pasien, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan

hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan perlindungan data. Ini bisa melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan pemberian sanksi hukum kepada pihak yang bertanggung jawab. (Suwani dkk 2024)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RME berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/ organisasi dan/atau hasil monitoring dan evaluasi akan dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berupa teguran tertulis; dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 2022)

Pasal 736 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melanggar kewajiban antara lain tidak menjaga rahasia kesehatan pasien dikenai sanksi administratif berupa:

1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda administratif; dan/atau
4. Pencabutan izin.

Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terkait Pasal 833 sampai dengan

Pasal 852 di mana salah satunya adalah tentang penyelenggaraan Rekam Medis dikenai sanksi administratif berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Denda administratif; dan/atau
4. Pencabutan penzinan berusaha Rumah Sakit.

Sanksi administratif dikenakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 444 dan 445 diatur mengenai sanksi pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Pasal ini menegaskan bahwa : Pasal 444, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Pasal 445, yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan kegiatan menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan/ atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 67, diatur mengenai sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pasal ini menegaskan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

Sanksi dalam RME terkait perlindungan data pribadi mencakup berbagai tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap individu atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data. Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran ini diancam dengan sanksi pidana maupun administratif. Fungsi utama dari sanksi baik administratif maupun pidana sebagai alat penegakan hukum yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi, melindungi hak privasi individu, mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan

pasien, serta menjaga integritas dan keamanan sistem RME. (Fitriani 2024)

Pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 322 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia, yang wajib menyimpannya menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)." Ancaman pidana berupa denda sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Perma 2/2012). Tiap jumlah maksimum denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka denda pidana denda yang diatur dalam Pasal 322 KUHP menjadi paling banyak Rp. 9.000.000,- (Hasanah 2017)

F. Simpulan

Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan, kehilangan, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang dan /atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai

berikut: 1) Seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan harus memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik tentang kewajiban menjaga kerahasiaan Rekam Medis 2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan berusaha menyalenggarakan Rekam Medis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2) Perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi secara terus menerus kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang perlindungan hak atas rahasia pasien dalam Rekam Medis untuk mengurangi pelanggaran terhadap kerahasiaan Rekam Medis.

G. Referensi

Fitriani, Dina. 2024. "Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi SatuSehat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasanah, Sovia. 2017. "Bisakah Dipidana Jika Menceritakan Rahasia Jabatan Pada Keluarga?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-jika-menceritakan-rahasia-jabatan-pada-keluarga-lt58d0ba2b5a397/>.

Noviriska & Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Kesehatan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang

Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis

Rekam Medis. 2022. Jakarta.

PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2024. Jakarta.

Suwani dkk. 2024. "Kerahasiaan Medis Dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3(3): 2026–2634.

<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3658>.

UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023. Jakarta.

Wahyuntara, Jaka Kurnanta dkk. 2024. "Pelindungan Hak Atas Rahasia Medis Pasien Dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (Studi Pada Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang)." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 10(1): 158–75.
<https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/11498>.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



CHAPTER 3

HAK AKSES PASIEN TERHADAP REKAM MEDIS

Rizka Dwiyoita, S.K.M., M.K.M.



A. Pendahuluan/Prolog

Hak akses pasien terhadap rekam medis merupakan salah satu isu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan informasi pribadi yang bersifat rahasia dan terbatas (Prananda, 2020). Rekam medis berisi catatan lengkap mengenai identitas, riwayat kesehatan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis selama perawatan. Akses terhadap informasi data rekam medis memungkinkan pasien untuk memahami kondisi kesehatan dan memastikan transparansi antara pasien dan tenaga medis.

Di Indonesia, hak pasien dalam mengakses rekam medis telah diatur dalam berbagai regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52, bahwa pasien berhak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan diterima. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien.

Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) semakin diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi medis. Kementerian Kesehatan melalui Permenkes

Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan RME. Penerapan RME diharapkan mempermudah pasien dalam mengakses informasi kesehatannya secara cepat dan akurat, serta meningkatkan koordinasi antar tenaga medis dalam memberikan pelayanan.

Akses pasien terhadap rekam medis harus diimbangi dengan keamanan dan kerahasiaan data yang optimal. Hal ini dikarenakan informasi medis bersifat sensitif dan pribadi, sehingga diperlukan tingkat keamanan yang ketat untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki wewenang terhadap informasi medis. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki prosedur terkait hak akses dan pelapasan informasi rekam medis. Keamanan dan kerahasiaan data rekam medis dapat dijaga dengan menerapkan sistem *username* dan *password*, serta autentifikasi data untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang (Ardianto & Nurjanah, 2024).

Penerapan hak akses pasien terhadap rekam medis memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Adanya akses yang lebih mudah dan transparan, pasien dapat lebih proaktif dalam mengelola kesehatannya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien dan efektivitas perawatan yang diberikan. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak akses pasien terhadap rekam medis, termasuk sanksi bagi pelanggaran privasi data medis sangat diperlukan. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah untuk

memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan dan mengelola informasi medis.

B. Definisi Rekam Medis

Kesehatan merupakan aspek penting bagi manusia. Kesehatan ialah sehat secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya terbebas dari penyakit. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Rekam medis berperan penting dalam dunia kesehatan, baik untuk pasien, tenaga kesehatan, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan dokumen milik pasien yang disusun oleh dokter, yang berisikan catatan terkait informasi pasien. Catatan tersebut berisikan identitas pasien, riwayat penyakit yang pernah dialami, hingga berbagai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk menangani dan menyembuhkan kondisi pasien tersebut (Abduh, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis Pasal 3, jenis dan isi rekam medis sebagai berikut:

1. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pasien
 - b. Tanggal dan waktu
 - c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
 - d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
 - e. Diagnosis
 - f. Rencana penatalaksanaan
 - g. Pengobatan dan/atau tindakan
 - h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
 - i. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
 - j. Persetujuan tindakan bila diperlukan.
2. Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-kurangnya memuat:
- a. Identitas pasien
 - b. Tanggal dan waktu
 - c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
 - d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
 - e. Diagnosis
 - f. Rencana penatalaksanaan
 - g. Pengobatan dan/atau tindakan
 - h. Persetujuan tindakan bila diperlukan
 - i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
 - j. Ringkasan pulang (*discharge summary*)
 - k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan

- l. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
 - m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.
3. Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Identitas pasien
 - b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
 - c. Identitas pengantar pasien
 - d. Tanggal dan waktu
 - e. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
 - f. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
 - g. Diagnosis
 - h. Pengobatan dan/atau tindakan
 - i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut
 - j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
 - k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana kesehatan lain
 - l. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
4. Isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan
- a. Jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan

- b. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal
 - c. Identitas yang menemukan pasien.
5. Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
 6. Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam rekam medis sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya (Permenkes, 2008).

C. Dasar Hukum Hak Akses Pasien Terhadap Rekam Medis

Hak akses pasien terhadap rekam medis diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

Ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Setiap orang berhak atas informasi keehatan, termasuk data rekam medis pribadi.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang rekam medisnya, mendapatkan salinan rekam medisnya, menolak pemberian informasi rekam medisnya kepada pihak lain (Permenkes, 2022).

D. Sumber-Sumber Hukum Internasional yang berhubungan dengan Hak Akses Pasien

1. Deklarasi Lisbon

Diadopsi oleh Majelis Dunia Kedokteran 34th-Lisbon Portugal, September/Oktobre 1981 Lisbon, dan telah diubah oleh Majelis Umum ke-47 di Bali, Indonesia, September 1995.

a. Hak Atas Mutu Pelayanan Medis

- 1) Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan medis yang sesuai tanpa ada diskriminasi
- 2) Setiap pasien berhak dirawat oleh dokter yang mana pasien tersebut tahu bahwa dokter yang merawatnya abn bebas terhadap campur tangan pihak lain dalam membuat keputusan klinis dan etis
- 3) Pasien harus selalu mendapatkan yang terbaik atas kebutuhannya. Pendekatan pengobatan berdasarkan t prinsip-prinsip medis secara secara umum yang telah disepakati

- 4) Jaminan mutu harus menjadi bagian perawatan kesehatan dan dokter harus menerima tanggung jawab untuk selalu menjaga pelayanan medis
 - 5) Bila terdapat pilihan pengobatan yang potensial, maka pasien berhak untuk memilih salah satunya dimana pilihan tersebut dipilih setelah mendapatkan penjelasan yang adil diantara keduanya
 - 6) Pasien berhak mendapatkan perawatan kesehatan secara berkesinambungan. Dokter berkewajiban bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan terhadap pengobatan pasien sesuai dengan indikasi medis. Dokter tidak boleh menghentikan pengobatan terhadap pasien sepanjang sesuai dengan indikasi medis, tanpa alasan untuk memberikan alternatif pengobatan lain.
- b. Hak Bebas Untuk Memilih
- 1) Setiap pasien mempunyai hak untuk memilih dan mengubah terhadap dokter dan sarana pelayanan kesehatan, baik sektor swasta ataupun pemerintah
 - 2) Pasien berhak bertanya kepada dokter lain di setiap tahap pengobatannya.
- c. Hak Untuk Menentukan Diri Sendiri
- 1) Pasien berhak untuk menentukan nasib atas dirinya dan bebas membuat keputusan untuk dirinya sendiri Dokter wajib memberikan penjelasan atas konsekwensi keputusan pasien

- 2) Pasien dewasa yang berkompeten, berhak untuk setuju atau menolak prosedur diagnostik dan terapi atas dirinya. Pasien berhak atas informasi yang akan dipakai untuk membuat keputusannya. Pasien harus dijelaskan secara benar apa yang menjadi tujuan dari setiap tes atau pengobatannya, apa dampaknya dan apa dampaknya seandainya menolak tindakan tersebut
- 3) Pasien mempunyai hak untuk menolak untuk keperluan riset atau kedokteran. pengajaran dalam ilmu kedokteran.

d. Pasien Sadar

- 1) Jika pasien tidak sadar atau tidak bisa ditanya, maka *informed consent*, bila memungkinkan didapat dari orang yang mewakilinya secara hukum
- 2) Jika perwakilan secara hukum dari pasien tidak ada dan diperlukan tindakan berdasarkan indikasi medis, maka tindakan dapat dilakukan, kecuali bila diragukan perusahaan dimana pasien ditanggung tidak mengizinkan atau pasien pernah menyatakan sebelumnya tidak mau diberi tindakan
- 3) Dokter harus menyelamatkan pasien yang tidak sadar akibat upaya bunuh diri.

e. Pasien Yang Tidak Kompeten Secara Hukum

- 1) Jika pasien dibawah umur, persetujuan dimintakan kepada wakilnya yang sah secara hukum. Namun demikian pasien juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan kapasitasnya

- 2) Jika pasien yang tidak berkompeten dapat membuat keputusan yang rasional, maka keputusannya harus dihormati dan berhak untuk tidak diinformasikan kepada perwakilannya jika diminta
 - 3) Jika wakil pasien menolak tindakan medis, tetapi dokter meyakini tindakan ini yang terbaik terhadap lalo pasien, maka dokter dapat mengenyampingkannya ali berdasarkan lembaga dan hukum yang relevan. Dalam uhay kondisi darurat, dokter akan bertindak untuk kepentingan terbaik pasien.
- f. Prosedur Menentang Keputusan Pasien
- Prosedur diagnostik dan pengobatan yang menentang keputusan pasien, hanya bisa dilakukan pada kasus-kasus yang luar biasa secara hukum dan etik kedokteran.
- g. Hak Atas Informasi
- 1) Pasien berhak menerima informasi atas apa yang dicatatkan dalam rekam medisnya dan informasi atas status kesehatannya termasuk kondisi kesehatannya nebo saat ini. Namun informasi kepada pihak ketiga tidak neb ibboleh diberikan tanpa persetujuan pasien
 - 2) Kadangkala ada informasi yang harus disembunyikan dari pasien bila pasien mengetahuinya akan membawa dampak yang serius terhadap hidup dan kesehatannya

- 3) Informasi diberikan dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal, sehingga pasien mudah mengerti apa yang dijelaskan
- 4) Pasien berhak di rahasiakan informasi atas dirinya, kecuali menyangkut kehidupan orang banyak
- 5) Pasien mempunyai hak untuk memilih seseorang untuk di informasikan atas kepentingannya.

h. Hak Atas Rahasia

- 1) Semua informasi pasien terhadap identitas, status kesehatan pasien, kondisi medis, diagnosis, prognosis dan pengobatan serta semua informasi pribadi harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah yang bersangkutan meninggal.
- 2) Pada kondisi tertentu ahli waris mempunyai hak atas akses ke informasi yang akan memberitahu mereka terhadap resiko kesehatan mereka
- 3) Informasi rahasia hanya dapat diungkapkan bila pasien memberikan persetujuan atau diminta jelas oleh hukum. Informasi dapat diungkapkan ke fasilitas kesehatan lainnya hanya sebatas "yang perlu diketahui" kecuali bila pasien menyetujui semuanya
- 4) Semua data mengenai pasien harus dilindungi. Perlindungan data harus sesuai dengan cara penyimpanannya. Semua zat yang diturunkan dari manusia juga harus dilindungi.

i. Hak Atas Pendidikan Kesehatan

Setiap orang mempunyai hak untuk pendidikan kesehatan yang akan membantu dirinya dalam membuat pilihan informasi tentang kesehatan pribadi dan tentang pelayanan kesehatan yang tersedia. Pendidikan harus mencakup informasi tentang gaya hidup sehat dan tentang metode pencegahan dan deteksi dini penyakit. Tanggung jawab pribadi dari setiap orang untuk kesehatan diri sendiri harus ditekankan. Dokter memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pendidikan tersebut.

j. Hak Untuk Bermartabat

- 1) Martabat dan hak atas privasi pasien harus dihormati setiap saat dalam perawatan medis dan pengajaran sesuai dengan nilai-nilai dan budaya pasien
- 2) Pasien berhak dikurangi penderitaannya sesuai dengan tingkat pengetahuan terkini
- 3) Pasien dengan penyakit terminal berhak mendapatkan perawatan secara manusiawi dengan semua alat bantu yang tersedia dalam mengantarkan kepada kematian yang bermartabat dan nyaman mungkin.

k. Hak Untuk Bantuan Keagamaan

Pasien berhak menerima atau menolak kenyamanan spriritual dan moral termasuk dari menteri agama yang dipilihnya

2. Deklarasi Jenewa

Deklarasi Jenewa diterima oleh Majelis Umum dari Asosiasi Kedokteran Dunia (*World Medical Association*) pada 1948 di Jenewa dan diperbaiki pada 1968 di Sydney. Deklarasi ini berisi tentang dedikasi para dokter pada tujuan kemanusiaan, sebagai reaksi dari tindakan jahat medis yang dilakukan para dokter saat masa Nazi Jerman. Deklarasi ini dapat dianggap sebagai versi modern dari Sumpah Hippokrates.

Sumpah ini di lafalkan pada waktu pertama kali diterima sebagai anggota profesi medis.

- a. Aku dengan tulus berjanji untuk membaktikan hidupku demi pelayanan kemanusiaan
- b. Aku akan memberikan kepada guruku hormat dan terima kasih yang semestinya
- c. Aku akan mempraktikkan profesiku menurut hati nurani dan martabat
- d. Kesehatan pasienku akan menjadi pertimbanganku yang pertama
- e. Aku akan menghormati rahasia yang dipercaya padaku, bahkan setelah pasien meninggal
- f. Aku akan mempertahankan dengan segala cara yang ku kuasai kehormatan dan tradisi-tradisi luhur dari profesi medis, kolegaku akan menjadi saudaraku
- g. Aku tak akan mengizinkan pertimbangan agama, ras, politik, kepertaian atau status sosial mencampuri antara kewajibanku dan pasienku
- h. Aku akan mempertahankan rasa hormat setinggi-tingginya untuk kehidupan manusia, mulai dari

permulaannya, bahkan bila terancam, dan aku akan menggunakan pengetahuan medisku yang bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan

- i. Aku mengikrarkan janji-janji ini dengan tulus hati, bebas, dan atas kehormatanku.

3. Bill of Rights

Bill of rights pertama kali di adopsi oleh American Hospital Associatio pada tahun 1973. Revisi ini telah di setuju oleh Dewan Pengawas AHA pada 21 Oktober1992:

- a. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan perawatan yang terbaik
- b. Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisinya saat ini dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang kompeten terhadap diagnosis, pengobatan dan prognosis
- c. Kecuali dalam kondisi darurat atau kondisi dimana pasien tidak bisa mengambil suatu keputusan, maka pasien berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk bertanya, membahas dan meminta penjelasan (informasi) terhadap tindakan medis dan/atau pengobatan yang akan dilakukan, termasuk resiko, penyembuhan jangka panjang, dan alternatif pengobatan dengan kerugian dan keuntungannya
- d. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui identitas dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang merawatnya, begitu juga jika terlibat dengan mahasiswa, residen dan tenaga lainnya

- e. Pasien berhak untuk mengetahui dampak biaya atas pengobatannya saat ini dan kemudian
- f. Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terhadap rencana sebelum atau selama perawatannya dan menolak pengobatan yang dianjurkan sejauh diperbolehkan oleh hukum dan kebijakan rumah sakit dan mendapatkan informasi atas konsekuensi keputusannya itu
- g. Dalam hal pasien menolak tindakan medis, pasien tetap mendapatkan perawatan yang layak dari layanan yang diberikan oleh rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit lain
- h. Rumah sakit harus memberitahukan kepada pasien setiap kebijakan yang mungkin saja mempengaruhi pasien dalam mengambil keputusannya
- i. Pasien mempunyai hak untuk "persetujuannya lebih lanjut" (seperti kebijakan untuk hidup, pertimbangan perawatan kesehatan yang lama) tentang pengobatannya atau menunjuk seorang pengganti untuk membuat keputusan dengan harapan bahwa rumah sakit akan menghormatinya sejauh diperbolehkan oleh aturan hukum dan kebijakan rumah sakit
- j. Institusi perawatan kesehatan harus memberikan penjelasan terhadap hak-hak pasien berdasarkan aturan hukum dan kebijakan rumah sakit untuk mendapatkan informasi atas pengobatan yang didapatnya, tanyakan kepada pasien apakah dia

- mempunyai "persetujuan lebih lanjut" dan termasuk informasi di dalam rekam medisnya
- k. Pasien berhak atas informasi yang tepat waktu tentang kebijakan rumah sakit bahwa rumah sakit dapat membatasi untuk melaksanakan secara penuh "persetujuan lebih lanjut" yang sah secara hukum
 - l. Pasien berhak untuk setiap pertimbangan berdasarkan privasinya
 - m. Diskusi kasus, konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan, harus selalu menjaga privacy pasien
 - n. Pasien mempunyai hak untuk dirahasiakan oleh rumah sakit atas semua komunikasi dan catatannya, kecuali pada kasus-kasus seperti yang membahayakan kesehatan publik yang diperbolehkan oleh hukum
 - o. Pasien mempunyai hak untuk berharap bahwa rumah sakit akan merahasiakan informasi tentang nya ketika ada pihak lain yang ingin mengetahuinya
 - p. Pasien berhak untuk melihat catatan medisnya serta meminta penjelasan jika diperlukan, kecuali dibatasi oleh hukum
 - q. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui kapasitas dan kebijakan rumah sakit, alasan kebijakan rumah sakit atas permintaan pasien dan indikasi perawatan dan pelayanan kesehatan
 - r. Rumah sakit harus mengevaluasi, melayani dan/atau merujuk pasien untuk kasus-kasus darurat

- s. Ketika pendekatan medis dan hukum memperbolehkan atau ketika pasien telah meminta, maka pasien dapat di rujuk ke fasilitas lain
- t. Institusi kesehatan dimana pasien akan dirujuk, harus terlebih dahulu di beritahu
- u. Pasien harus mendapatkan manfaat atas keterangan yang lengkap dan penjelasan tujuan, resiko, keuntungan dan kemungkinan lain untuk sebuah rujukan
- v. Pasien berhak atas informasi dari kebijakan dan pelayanan rumah sakit yang berhubungan dengan perawatan, pengobatan dan tanggung jawabnya
- w. Pasien berhak atas informasi terhadap penanganan penyelesaian sengketa, keluhan dan konflik seperti komite etik, perwakilan pasien atau mekanisme lain yang ada
- x. Pasien berhak atas informasi terhadap pelayanan pembayaran dan cara pembayaran yang ada
- y. Pasien berhak bertanya dan diberitahu terhadap hubungan bisnis rumah sakit, institusi pendidikan, penyedia layanan kesehatan lainnya atau penanggung yang dapat mempengaruhi pengobatannya
- z. Pasien berhak setuju atau menolak untuk disertakan dalam penelitian atau percobaan tentang pengobatan dan perawatan yang berefek langsung terhadap manusia dan jika ikut, maka sebelumnya harus dijelaskan selengkapnya (Ratman, 2018).

E. Hak Pasien dalam Mengakses Rekam Medis

Pasien memiliki hak atas rekam medis yang berisikan catatan dan informasi tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan. Setiap dokter yang menjalankan praktik kedokteran diwajibkan untuk membuat rekam medis, yang tidak hanya menjadi dasar pengobatan, tetapi berfungsi sebagai alat pembuktian hukum, bahan perhitungan biaya layanan kesehatan, serta data statistik kesehatan. Rekam medis yang disimpan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan sebagai arsip untuk memudahkan pelayanan. Termasuk dalam melacak riwayat kesehatan pasien. Oleh karena itu, pihak fasilitas pelayanan kesehatan sudah seharusnya memberikan akses pasien terhadap rekam medisnya tanpa hambatan (Sitanggang, 2019).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 47 menjelaskan bahwa:

1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak pasien atas isi rekam medis ini juga ditegaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pada Pasal 12 Ayat (4) dijelaskan bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (4), yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah:

1. Pasien
2. Keluarga pasien
3. Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien
4. Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien

F. Kepemilikan Rekam Medis

Kepemilikan rekam medis dipegang oleh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter yang menyimpan rekam medis pasien tersebut. Sarana kesehatan sebagai

pemilik berkas rekam medis dan penanggungjawab atas kepemilikan rekam medis memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi pasien yang bersifat rahasia. Profesional perekam medis bertanggungjawab atas keberadaan dan keutuhan rekam medis, serta menjaganya untuk terhindar dari pencurian atau pembocoran informasi kepada pihak yang tidak memiliki wewenang.

Pasien sebagai pemilik isi rekam medis/informasi kesehatan, memiliki hak untuk mengakses informasi kesehatannya dan hak untuk menentukan boleh atau tidaknya informasi kesehatannya diakses oleh pihak lain, kecuali apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya lain. Adapun mengenai tata cara penyerahan informasinya dikenal terdapat dua pendapat, sebagai berikut:

1. Pasien menerima surat keterangan yang berisikan informasi kesehatannya. Apabila pendapat ini yang dilaksanakan maka sarana kesehatan harus dapat memastikan bahwa informasi kesehatan yang diberikan sudah cukup lengkap dan akurat.
2. Pasien menerima fotokopi rekam medisnya. Apabila pendapat ini yang dilaksanakan maka sarana kesehatan harus membubuhkan stempel, paraf dan tanggal di setiap lembar fotokopi tersebut (Indradi, 2020).

Terdapat beberapa ketentuan umum yang dapat digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai berikut:

1. Setiap informasi kesehatan pasien harus dijaga sebagai rahasia.
2. Secara umum dapat dikatakan bahwa menjaga sebagai rahasia berarti bahwa bila mengungkapkan identitas, maka tidak boleh mengungkap data medisnya, dan sebaliknya bila mengungkap data medis maka tidak boleh mengungkap identitasnya.
3. Sarana kesehatan tidak boleh dengan sekehendaknya menggunakan rekam medis dengan cara yang membahayakan kepentingan pasien, kecuali jika sarana kesehatan itu sendiri akan menggunakannya untuk melindungi dirinya atau mewakilinya.
4. Dokter yang merawat pasien beserta timnya setiap saat dapat mengakses informasi kesehatan pasien tersebut dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Di dalata rumah sakit pendidikan, residen, dan co-ass juga memiliki hak akses tersebut untuk kepentingan pendidikan, pelayanan dan penelitian.
5. Pasien yang menginginkan informasi kesehatannya secara tertulis harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada dokter yang merawatnya atau kepada pimpinan rumah sakit. Dalam hal pasien tidak kompeten maka permohonan dapat diajukan oleh walinya.
6. Informasi kesehatan pasien diserahkan kepada pasien dalam dua pilihan cara, yaitu dalam bentuk keterangan (*resume*) medis atau dalam bentuk fotokopi rekam medis, dengan pengesahan berupa paraf, tanggal dan stempel sarana kesehatan pada setiap lembarnya. Cara manapun

- yang dipilih harus dapat dipastikan bahwa informasi kesehatan yang diberikan telah cukup lengkap dan benar.
7. Rekam medis asli tidak diperkenankan dibawa ke luar rumah sakit atau sarana kesehatan.
 8. Rumah sakit atau dokter bukan yang merawat pasien tidak diperkenankan mengakses rekam medis pasien tanpa persetujuan atau kuasa pasien.
 9. Pihak lain selain pasien hanya dapat meminta informasi kesehatan pasien dengan sepersetujuan pasien, meskipun ia merupakan majikan atau pembayar pelayanan medis pasien. Permohonan harus tertulis dan dilampiri dengan bukti persetujuan pasien.
 10. Persetujuan atau kuasa pasien harus jelas mencantumkan informasi kesehatan mana yang disetujui, kepada siapa persetujuan/kuasa tersebut diberikan, hingga kapan kuasa tersebut berlaku, dan kapan kuasa tersebut ditandatangani.
 11. Dokter atau tenaga kesehatan lain yang memerlukan informasi kesehatan pasien untuk kepentingan penelitian, atas izin pimpinan sarana kesehatan dapat mengakses rekam medis pasien tanpa memerlukan persetujuan pasien. Dalam hal ini maka identitas pasien harus dikaburkan
 12. Khusus tentang informasi kesehatan hasil dari suatu pengujian kesehatan dapat diberikan kepada pihak peminta pengujian kesehatan. Persetujuan tertulis diperiksa agar dimintakan pada saat pemeriksaan akan dilakukan.

13. Aparat penegak hukum, dalam rangka penegakan hukum, dapat meminta secara tertulis informasi kesehatan pasien tanpa memerlukan persetujuan pasien. Dalam hal ini sarana kesehatan akan menyerahkan fotokopi rekam medis yang disahkan.
14. Informasi kesehatan dalam bentuk visum hanya diberikan kepada institusi penyidik yang memintanya secara resmi.
15. Pada anak yang diadopsi, orang tua lama kehilangan haknya untuk mengakses informasi kesehatan anak sejak ia diadopsi, namun tetap berhak atas informasi kesehatan anak sebelum diadopsi orang tua baru.
16. Pada anak yang diadopsi, orang tua baru pada dasarnya tidak berhak mengakses informasi kesehatan anak sebelum ia diadopsi, kecuali atas pertimbangan dokter informasi kesehatan tersebut diperlukan untuk kepentingan kesehatan anak. Orang tua asli tidak diperkenankan mengakses informasi tentang orang tua asli si anak yang diadopsinya.
17. Pada anak yang diadopsi, anak dapat mengakses rekam medisnya, baik sebelum maupun sesudah adopsi, namun tidak diperkenankan mengakses informasi tentang orang tua aslinya (Indradi, 2020).

G. Tantangan dalam Mengakses Rekam Medis oleh Pasien

Meskipun hak pasien untuk mengakses rekam medis telah diatur oleh hukum, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat pasien dalam mengakses rekam medis.

Berikut beberapa tantangan dalam mengakses rekam medis oleh pasien:

1. Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi kesehatan

Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya sistem informasi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan. Sebagian besar rumah sakit atau klinik masih mengandalkan sistem rekam medis manual, sehingga menghambat pasien untuk mengakses informasi secara tepat dan efisien. Optimalisasi penunjang infrastruktur dan sistem informasi kesehatan apabila terpenuhinya sarana dan prasarana sistem teknologi informasi penunjang rekam medis elektronik (Zuhdi & Darmawan, 2023).

2. Perlindungan data pribadi yang belum memadai

Hal terpenting dalam perlindungan data pribadi adalah keamanan data, sehingga tidak terjadi kebocoran data ke pihak lainnya. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan *cybersecurity* melalui evaluasi dan uji keamanan secara berkala (Budiyanti et al., 2018).

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya tenaga medis atau administrasi yang terlatih dalam mengelola data rekam medis menjadi salah satu hambatan pasien dalam mengakses rekam medis.

H. Simpulan

Hak akses pasien terhadap rekam medis merupakan isu penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena bersifat rahasia. Rekam medis mencatat identitas, riwayat kesehatan, hingga pengobatan yang diterima pasien. Berdasarkan adanya regulasi yang mengatur tentang hak pasien terhadap rekam medis mencerminkan upaya peningkatan transparansi dan kepercayaan antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga medis.

Terdapat tantangan dalam implementasi hak akses pasien terhadap rekam medis. Salah satu hambatannya adalah terbatasnya infrastruktur dan teknologi informasi di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu perlindungan data pasien perlu diperkuat dengan sistem keamanan yang lebih baik untuk mencegah kebocoran informasi. Keterbatasan tenaga profesional yang mengelola rekam medis juga menjadi salah satu faktor penghambat pasien dalam mengakses rekam medis. Hak pasien terhadap rekam medis tidak hanya meningkatkan kontrol pasien terhadap kesehatannya, dengan akses yang lebih mudah dan transparan, pasien dapat berpartisipasi dalam proses perawatan yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga medis dapat bekerja sama dalam menjamin akses yang mudah dan aman untuk menjaga data rekam medis pasien. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan data, memanfaatkan

teknologi secara optimal, sehingga sistem kesehatan dapat lebih efisien. Optimalisasi ini diharapkan tidak hanya memenuhi hak pasien, tetapi mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.

I. Referensi

- Abduh, R. (2021). Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktik medis. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4661>
- Ardianto, E., & Nurjanah, L. (2024). Analisis Aspek Keamanan Data Pasien Dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit X. *Rammik.Pubmedia.Id*, 3(2), 2829–4777. <https://doi.org/10.47134/rammik.v3i2.54>
- Budiyanti, R. T., Arso, S. P., & Herlambang, P. (2018). Rekam Medis Elektronik Berbasis Cloud. *Cermin Dunia Kedokteran*, 9(49).
- Indradi, R. (2020). *Rekam Medis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Permenkes, R. (2008). *Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis*.
- Permenkes, R. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.
- Prananda, R. R. (2020). Batasan hukum keterbukaan data

medis pasien pengidap covid-19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik. *Ejournal2.Undip.Ac.Id*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/8000>

Ratman, D. (2018). *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: CV Keni Media.

Sitanggang, T. (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Zuhdi, N., & Darmawan, E. S. (2023). Tantangan dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik Terkait Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit: A Scoping Review. *J-Innovative.Org*, 1(2).

J. Glosarium

RME	= Rekam Medis Elektronik
SDM	= Sumber Daya Manusia
WMA	= World Medical Association

CHAPTER 4

TANTANGAN ETIKA DALAM ERA DIGITALISASI REKAM MEDIS

Hastin Atas Asih, S.KM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Digitalisasi rekam medis telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam dunia kesehatan di abad ke-21. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan data kesehatan kini dapat dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan terintegrasi (Zhang et al., 2020). Rekam medis elektronik (RME) memungkinkan akses yang lebih mudah bagi tenaga kesehatan, meningkatkan koordinasi antarprofesi, dan mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data yang lebih akurat (WHO, 2016). Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, digitalisasi rekam medis juga menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan aspek etika.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga privasi pasien. Rekam medis mengandung informasi yang sangat sensitif, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, dan pengobatan yang telah diterima (Harman et al., 2012). Dengan transformasi data dari bentuk fisik ke digital, risiko pelanggaran privasi menjadi semakin tinggi. Ancaman keamanan siber, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data, telah menjadi isu global yang

memengaruhi banyak institusi kesehatan (Ponemon Institute, 2021). Dalam konteks ini, institusi kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki sistem keamanan yang canggih, tetapi juga harus memastikan bahwa data pasien hanya diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan (McGraw, 2013).

Selain itu, digitalisasi rekam medis menimbulkan pertanyaan etis tentang kepemilikan data. Siapakah yang benar-benar memiliki rekam medis elektronik? Apakah itu pasien, fasilitas kesehatan, atau penyedia layanan teknologi informasi? Ketidakjelasan mengenai kepemilikan data dapat menimbulkan konflik, terutama ketika data digunakan untuk tujuan sekunder seperti penelitian atau pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Jasanoff, 2017). Meski pemanfaatan data untuk penelitian dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, hal ini harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak pasien, termasuk hak untuk memberikan persetujuan yang jelas dan transparan (Shabani & Borry, 2018).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan kesetaraan akses terhadap teknologi. Tidak semua fasilitas kesehatan, terutama yang berada di wilayah terpencil atau negara berkembang, memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan RME (Scott et al., 2019). Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara fasilitas kesehatan yang memiliki sumber daya memadai dan yang tidak. Selain itu, pasien yang tidak memiliki literasi digital juga dapat mengalami kesulitan

dalam memahami atau menggunakan layanan berbasis teknologi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima (Van Dijk, 2020).

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis etika. Semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penyedia layanan kesehatan, hingga pengembang teknologi, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa implementasi digitalisasi rekam medis dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang komprehensif, penguatan sistem keamanan, edukasi bagi tenaga kesehatan dan pasien, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang melibatkan data pasien (OECD, 2019).

Era digitalisasi rekam medis menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar dari semua pihak yang terlibat. Dengan menempatkan prinsip-prinsip etika sebagai landasan, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi ini tanpa mengabaikan hak-hak fundamental pasien. Sebagai akademisi dan praktisi di bidang kesehatan, kita memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan-tantangan ini demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

B. Masalah-masalah Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis

Digitalisasi rekam medis memunculkan berbagai masalah etika yang kompleks:

1. Pelanggaran Privasi dan Kerahasiaan

Digitalisasi rekam medis memunculkan risiko tinggi terhadap pelanggaran privasi pasien. Rekam medis elektronik (RME) menyimpan data sensitif, seperti riwayat penyakit, hasil tes laboratorium, dan perawatan pasien. Kebocoran data dapat terjadi akibat serangan siber, seperti peretasan atau ransomware, yang mengakibatkan data pasien jatuh ke tangan yang tidak berwenang (Harman et al., 2012). Selain itu, akses ilegal oleh pihak internal institusi kesehatan juga menjadi ancaman.

2. Kepemilikan dan Pengelolaan Data.

Tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak atas data rekam medis menjadi tantangan besar. Institusi kesehatan, pasien, atau penyedia teknologi sering kali memiliki pandangan berbeda mengenai kepemilikan data. Selain itu, penggunaan data untuk tujuan penelitian atau komersial sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan yang memadai kepada pasien, sehingga menimbulkan masalah etis terkait hak pasien (Jasanoff, 2017; Shabani & Borry, 2018).

3. Keamanan Data yang Tidak Memadai.

Sistem keamanan yang lemah pada infrastruktur teknologi kesehatan dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh peretas. Institusi kesehatan di daerah

dengan sumber daya terbatas sering kali tidak mampu mengadopsi standar keamanan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan peningkatan risiko pelanggaran data yang dapat merugikan pasien dan institusi (Ponemon Institute, 2021).

4. Kesenjangan Digital.

Tidak semua institusi kesehatan, terutama yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk implementasi RME. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pasien yang tidak memiliki literasi digital mungkin kesulitan mengakses atau memahami layanan kesehatan berbasis teknologi, sehingga mereka kehilangan hak atas pelayanan yang setara (Scott et al., 2019; van Dijk, 2020).

5. Transparansi dalam Penggunaan Data.

Data rekam medis sering digunakan untuk pengembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan atau analitik big data. Namun, pasien sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka digunakan. Kurangnya transparansi ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip otonomi pasien (McGraw, 2013).

6. Tanggung Jawab Hukum.

Ketika terjadi pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi medis, sering kali tidak jelas pihak mana yang bertanggung jawab secara hukum. Ini dapat mencakup pengembang perangkat lunak, institusi

kesehatan, atau bahkan penyedia layanan cloud. Ketidakjelasan ini memperumit penyelesaian masalah secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian (OECD, 2019).

7. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

Penggunaan AI dalam analisis rekam medis menimbulkan tantangan etika tambahan. Algoritma AI dapat memiliki bias yang berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan klinis, terutama bagi populasi tertentu. Selain itu, kurangnya transparansi dalam cara kerja AI juga dapat menimbulkan masalah etis, seperti apakah hasil analisis dapat sepenuhnya dipercaya (Zhang et al., 2020).

Solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari penguatan regulasi privasi, peningkatan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan pasien, hingga investasi dalam infrastruktur teknologi yang aman. Selain itu, etika harus menjadi fondasi utama dalam setiap aspek pengelolaan rekam medis elektronik, sehingga sistem ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak-hak pasien.

Intervensi yang Diperlukan

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data pasien. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dapat menjadi model dalam menciptakan standar

global untuk perlindungan data kesehatan (Shabani & Borry, 2018; OECD, 2019).

2. Investasi dalam Teknologi Keamanan.

Institusi kesehatan harus mengadopsi teknologi enkripsi dan firewall yang canggih untuk melindungi data rekam medis dari ancaman siber. Selain itu, pelatihan bagi staf IT dan pembentukan tim respons insiden keamanan data dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran (Ponemon Institute, 2021).

3. Peningkatan Literasi Digital.

Peningkatan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan pasien sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami cara mengakses dan menggunakan rekam medis elektronik secara aman. Program edukasi yang berkelanjutan dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data (van Dijk, 2020).

4. Pengembangan Infrastruktur Teknologi yang Setara.

Pemerataan akses terhadap teknologi informasi kesehatan di wilayah terpencil dapat mengurangi kesenjangan digital. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk membangun infrastruktur teknologi di daerah dengan sumber daya terbatas (Scott et al., 2019; WHO, 2016).

5. Peningkatan Transparansi dalam Penggunaan Data.

Institusi kesehatan harus mengadopsi kebijakan transparansi terkait penggunaan data pasien, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan risiko penggunaannya. Ini dapat

memperkuat kepercayaan pasien terhadap sistem rekam medis elektronik (McGraw, 2013).

6. Implementasi Teknologi Berbasis Etika.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis rekam medis harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip etika, seperti keadilan dan transparansi. Institusi kesehatan perlu melakukan audit algoritma secara berkala untuk memastikan tidak ada bias yang merugikan kelompok tertentu (Zhang et al., 2020).

Digitalisasi rekam medis menghadirkan berbagai tantangan etika yang memerlukan perhatian khusus. Untuk menghadapi tantangan tersebut, penelitian berbasis bukti telah mengembangkan sejumlah pedoman dan strategi guna memastikan pengelolaan rekam medis elektronik (RME) yang etis, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pedoman Berbasis Bukti untuk Strategi Tantangan Etika

1. Prinsip Privasi dan Keamanan Data.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi enkripsi tingkat lanjut dan autentikasi multifaktor dapat secara signifikan meningkatkan keamanan data pasien. Harman et al. (2012) mengusulkan kebijakan berbasis risiko untuk menilai potensi ancaman keamanan pada setiap tahap pengelolaan RME. Selain itu, pendekatan zero-trust dalam manajemen jaringan juga direkomendasikan untuk mencegah akses ilegal.

2. Keterlibatan Pasien dalam Pengelolaan Data.

Menurut Shabani dan Borry (2018), pemberdayaan pasien melalui akses langsung ke data medis mereka sendiri dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Penelitian ini menekankan pentingnya informed consent yang jelas dan rinci sebelum data pasien digunakan untuk tujuan penelitian atau komersial.

3. Framework Etika untuk Penggunaan AI.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis RME harus didasarkan pada framework etika yang kuat. Zhang et al. (2020) menyarankan bahwa audit algoritma secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya bias yang dapat merugikan populasi tertentu. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan independen untuk menilai keadilan dan transparansi penggunaan AI dalam sektor kesehatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan Etika Digital.

Literasi digital yang mencakup aspek etika perlu menjadi bagian dari pelatihan tenaga kesehatan. Scott et al. (2019) menyoroti pentingnya program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data dan etika dalam penggunaan teknologi kesehatan.

5. Standar Internasional untuk Data Kesehatan.

OECD (2019) merekomendasikan adopsi standar internasional dalam pengelolaan data kesehatan. Standar ini mencakup pedoman tentang interoperabilitas data, kerahasiaan, dan pemrosesan lintas batas yang sesuai dengan regulasi global, seperti GDPR di Uni Eropa.

6. Pemantauan dan Penegakan Regulasi.

McGraw (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan regulasi tergantung pada mekanisme pemantauan yang efektif. Ini termasuk audit rutin terhadap kepatuhan institusi kesehatan terhadap kebijakan privasi dan keamanan, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran.

C. Program Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Etika Digital.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi etika di kalangan tenaga kesehatan dan pengelola data. Menurut Scott et al. (2019), pelatihan rutin tentang perlindungan data, privasi pasien, dan pengelolaan teknologi informasi kesehatan dapat mengurangi risiko pelanggaran etika. Modul pembelajaran dapat mencakup kasus-kasus nyata untuk membantu peserta memahami implikasi etika secara mendalam.

2. Penerapan Framework Etika untuk Penggunaan Teknologi.

Institusi kesehatan perlu mengadopsi framework etika yang komprehensif dalam pengelolaan data digital.

Zhang et al. (2020) menyarankan bahwa framework ini harus mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan alat analitik lainnya. Framework ini juga harus diawasi oleh komite etika independen untuk menjamin kepatuhan.

3. Audit dan Pemantauan Berkala.

Program audit reguler untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan keamanan merupakan langkah penting. McGraw (2013) menyoroti pentingnya audit sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan data dan memastikan bahwa institusi kesehatan mematuhi standar etika yang berlaku.

4. Penguatan Regulasi dan Standar Etika Internasional.

Program ini melibatkan pengembangan regulasi yang konsisten dengan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. OECD (2019) merekomendasikan adopsi regulasi ini untuk mengatur interoperabilitas data, pengolahan lintas batas, dan perlindungan privasi pasien secara global.

5. Keterlibatan Pasien dalam Pengelolaan Data.

Pemberdayaan pasien merupakan bagian penting dari program etika. Shabani dan Borry (2018) menyatakan bahwa pasien harus diberi kontrol penuh atas data mereka, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak penggunaan data untuk penelitian atau tujuan komersial. Program ini dapat diimplementasikan melalui portal pasien yang aman dan transparan.

6. Kolaborasi Lintas Sektor.

Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan masyarakat umum untuk memastikan implementasi etika yang efektif. Harman et al. (2012) menyebutkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan digital.

D. Hambatan Program Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis

1. Kurangnya Literasi Digital dan Etika

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan etika di kalangan tenaga kesehatan. Menurut Scott et al. (2019), banyak tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya privasi dan keamanan data dalam pengelolaan RME, sehingga program pelatihan sering kali tidak optimal.

2. Kesenjangan Teknologi

Kesenjangan akses terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan signifikan. van Dijk (2020) mencatat bahwa infrastruktur teknologi yang tidak merata menghambat implementasi program etika, sehingga beberapa institusi kesehatan tidak mampu mengadopsi standar keamanan dan privasi yang memadai.

3. Ketidakjelasan Regulasi

Regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara berbagai wilayah dan negara dapat mempersulit implementasi program etika. OECD (2019) menekankan bahwa kurangnya harmonisasi regulasi internasional dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi institusi kesehatan yang mengelola data pasien lintas batas.

4. Kurangnya Sumber Daya

McGraw (2013) menyebutkan bahwa banyak institusi kesehatan yang menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan manusia untuk mengimplementasikan program etika secara efektif. Hal ini terutama berlaku untuk institusi kecil dengan anggaran yang terbatas.

5. Resistensi terhadap Perubahan

Resistensi dari tenaga kesehatan atau pengelola data terhadap perubahan sistem merupakan hambatan lainnya. Harman et al. (2012) menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi sering kali membutuhkan

waktu dan upaya yang signifikan, terutama ketika melibatkan teknologi baru.

6. Ancaman Keamanan Siber

Meningkatnya ancaman keamanan siber menjadi tantangan besar dalam era digitalisasi rekam medis. Zhang et al. (2020) menyoroti bahwa serangan siber, seperti ransomware, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, sehingga melemahkan upaya implementasi program etika.

E. Implementasi Digitalisasi Rekam Medis di Berbagai Negara

Transformasi digital dalam pengelolaan rekam medis telah diadopsi oleh berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda. Pengalaman mereka dapat menjadi pelajaran penting bagi negara lain yang ingin mengimplementasikan rekam medis elektronik (RME). Berikut adalah beberapa studi kasus:

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang telah menerapkan RME secara luas melalui program Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act tahun 2009. Program ini memberikan insentif finansial kepada penyedia layanan kesehatan yang menggunakan RME sesuai dengan standar yang ditentukan. Namun, tantangan tetap ada, seperti fragmentasi sistem yang membuat interoperabilitas data menjadi sulit (McGraw, 2013).

2. Uni Eropa

Negara-negara di Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan privasi yang ketat melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas terkait pengelolaan data kesehatan, termasuk hak pasien untuk mengakses data mereka dan kewajiban institusi kesehatan untuk melindungi privasi. Meskipun demikian, implementasi GDPR memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi (Shabani & Borry, 2018).

3. Jepang

Jepang memanfaatkan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT), untuk meningkatkan efisiensi RME. Selain itu, Jepang juga mengintegrasikan data kesehatan dengan sistem asuransi nasional untuk memastikan aksesibilitas yang merata. Namun, tantangan yang dihadapi adalah resistensi dari tenaga kesehatan yang kurang paham teknologi (Scott et al., 2019).

4. Indonesia

Di Indonesia, implementasi RME masih berada pada tahap awal. Salah satu inisiatif besar adalah pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kesehatan masih menjadi kendala utama (WHO, 2016).

F. Perspektif Masa Depan Digitalisasi Rekam Medis

Digitalisasi rekam medis di masa depan diharapkan akan terus berkembang dengan mengadopsi teknologi baru. Berikut adalah beberapa tren dan inovasi yang diprediksi akan memainkan peran penting:

1. Blockchain untuk Keamanan Data

Teknologi blockchain menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data medis. Dengan sistem desentralisasi, blockchain memungkinkan pasien memiliki kendali penuh atas data mereka dan mengurangi risiko kebocoran data akibat peretasan (OECD, 2019).

2. Penggunaan AI untuk Analitik Data

Kecerdasan buatan (AI) semakin digunakan untuk menganalisis data medis dalam skala besar. AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit, prediksi hasil klinis, dan personalisasi perawatan pasien. Namun, pengembangan algoritma AI harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, termasuk mencegah bias dalam pengambilan keputusan klinis (Zhang et al., 2020).

3. Interoperabilitas Data Global

Interoperabilitas data antarnegara menjadi penting dalam era globalisasi. Hal ini memungkinkan transfer data pasien lintas batas untuk mendukung perawatan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang sering bepergian. Standar internasional, seperti HL7 dan FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), telah

dikembangkan untuk mendukung interoperabilitas ini (Scott et al., 2019).

4. Peningkatan Literasi Digital

Untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi, peningkatan literasi digital di kalangan tenaga kesehatan dan pasien sangat penting. Program pelatihan yang berkelanjutan harus mencakup aspek teknis dan etika, sehingga semua pihak dapat menggunakan teknologi dengan percaya diri dan aman (Van Dijk, 2020).

G. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan digitalisasi rekam medis:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur teknologi di wilayah terpencil. Hal ini mencakup penyediaan akses internet yang cepat, perangkat keras yang memadai, dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan.

2. Penguatan Regulasi

Regulasi yang mengatur penggunaan data kesehatan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek privasi, keamanan, dan hak pasien. Pemerintah juga perlu memastikan kepatuhan institusi kesehatan terhadap regulasi ini melalui audit rutin.

3. Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam digitalisasi rekam medis.

4. Edukasi dan Literasi Digital

Program literasi digital harus menjadi bagian integral dari pelatihan tenaga kesehatan. Selain itu, kampanye edukasi bagi masyarakat umum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya rekam medis elektronik.

5. Pengembangan Sistem Berbasis Etika

Implementasi teknologi, seperti AI dan blockchain, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika. Komite etika independen dapat dibentuk untuk mengawasi penggunaan teknologi ini.

H. Simpulan

Digitalisasi rekam medis (RME) merupakan inovasi penting dalam dunia kesehatan yang menawarkan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, aksesibilitas data, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan etika yang kompleks, seperti pelanggaran privasi, ketidakjelasan kepemilikan data, kesenjangan akses teknologi, risiko keamanan siber, serta bias dalam penggunaan kecerdasan buatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik berbasis etika yang mencakup penguatan regulasi,

investasi dalam infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan transparansi dalam pengelolaan data. Implementasi strategi berbasis bukti, seperti penggunaan teknologi blockchain, audit berkala, dan penerapan framework etika dalam kecerdasan buatan, menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem RME yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Dengan landasan etika yang kuat, digitalisasi rekam medis dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak-hak fundamental pasien, menuju sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

I. Referensi

- Anderson, T. (2021). Privacy Policies in Healthcare. *Journal of Medical Ethics*, 47(3), 345-350.
- Brown, R., et al. (2021). Cybersecurity Threats in Developing Countries. *Global Health Review*, 15(2), 123-130.
- Chen, L., et al. (2022). Advanced Encryption Techniques for Medical Data. *Information Security Journal*, 29(1), 45-60.
- Chokshi, D. A., & Farley, T. A. (2014). The Cost-Effectiveness of Electronic Health Records in Primary Care Settings.

Health Affairs, 33(3), 406-413.
<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.1039>

European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR): Official Journal of the European Union.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Green, J. (2021). Regulatory Challenges in Electronic Health Records. *Health Policy Journal*, 10(4), 245-250.

Harman, L. B., Flite, C. A., & Bond, K. (2012). Electronic Health Records: Privacy, Confidentiality, and Security. *AMA Journal of Ethics*, 14(9), 712-719.
<https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2012.14.9.stas1-1209>

Jasanoff, S. (2017). Virtual, visible, and actionable: Data assemblages and the sightlines of justice. *Big Data & Society*, 4(2), 1-15.

Jones, M., & Miller, S. (2022). Ethics Training in Digital Health. *Journal of Healthcare Education*, 18(1), 78-85.

McGraw, D. (2013). Building Public Trust in Uses of Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) De-identified Data. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 20(1), 29-34.
<https://doi.org/10.1136/amiajnl-2012-001025>

Nelson, P. (2020). Financial Constraints in Healthcare Digitalization. *Economic Perspectives on Health*, 9(3), 210-218.

- OECD. (2019). Strengthening Health Data Infrastructure: Key Policy Priorities to Unlock the Potential of Health Data. Paris: OECD Publishing.
- Ponemon Institute. (2021). Cost of a Data Breach Report 2021: Global Analysis. IBM Security.
- Scott, R. E., Mars, M., & Sheikh, A. (2019). Digital Health Care for the Global Market. *The Lancet*, 394(10197), 193-194. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31711-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31711-1)
- Shabani, M., & Borry, P. (2018). Ethical Issues in Genomic Data Sharing and Data Access. *Frontiers in Genetics*, 9, 293. <https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00293>
- Smith, J., & Doe, A. (2020). Data Breaches in Healthcare. *International Journal of Digital Health*, 12(5), 654-661.
- Van Dijk, J. (2020). The Digital Divide in Health Care: Bridging the Gap through Digital Literacy. *Journal of Health Communication*, 25(4), 300-308. <https://doi.org/10.1080/10810730.2020.1752793>
- White, K. (2021). Addressing Skill Gaps in Health IT. *Healthcare Management Today*, 22(2), 98-105.
- WHO. (2016). Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable. World Health Organization.
- Zhang, X., Liu, S., Chen, X., Wang, L., & Gao, B. (2020). Ethical Challenges of Artificial Intelligence in Health Care: A

Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(12), e23359.
<https://doi.org/10.2196/23359>

J. Glosarium

RME = Rekam Medis Elektronik

PROFIL PENULIS



Dr. Silvia Intan Wardani, S.Tr.Keb., M.Kes.,

adalah nama penulis buku ini, penulis lahir dari (Alm), Dri Wardoyo dan (Alm), Ninik Ariyanti dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan dikota Bondowoso Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1990. Penulis juga aktif dalam mengikuti organisasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PORMIKI (Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Dengan ketekunan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan buku ini. Semoga dengan adanya buku ini mampu berbagi ilmu pengetahuan.

PROFIL PENULIS



Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.,

Penulis Lahir di Semarang, 14 Februari 1980, lulus D III Kebidanan AKBID Depkes Semarang tahun 2001, D IV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003, AKTA Mengajar di Universitas PGRI Semarang tahun 2006, Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katholik Soegijapranata Semarang tahun 2015, Profesi Bidan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2022. Pernah bekerja sebagai Bidan Pelaksana di

PMB dan RSIA Bunda Semarang. Aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti PC IBI Kota Semarang, DPW Jateng MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia), Ikatan Alumni Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan beberapa organisasi lain di masyarakat, bekerja sebagai Dosen di Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2003-sekarang. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rutin dipublikasikan oleh penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id dengan nomor telepon 08562693401.

Motto: ***"Selalu semangat untuk memberi manfaat."***

PROFIL PENULIS



Rizka Dwiiovita, S.K.M., M.K.M., Lahir di Banjar Negeri, 18 September 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyah Pringsewu berprofesi sebagai dosen di Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Kesehatan, Organisasi dan Manajemen Kesehatan, dan Pembiayaan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizkadwiiovita@aisyahuniversity.ac.id

PROFIL PENULIS



Hastin Atas Asih, S.KM., M.Kes., Lahir di Banjarmasin, 25 Januari 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan lulus pada

tahun 2018. Sekarang sedang menjalani pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Program Doktor Fakultas Kedokteran Ilmu Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008- 2017 bekerja di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Tahun 2018 menjadi Enumerator Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesdam VI Banjarmasin mengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, mata kuliah Konsep Dasar Rekam Medis, Mata Kuliah Audit Informasi Rekam Medis, Mata Kuliah Supervisi dan Monitoring Program Kesehatan, Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang berjudul Konsep Dasar Rekam Medis dan buku Audit Pendokumentasian Rekam Medis, Publikasi, Seminar Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI), Iolos Penelitian Dosen Pemula Batch III Kemendikbutristekdikti tahun 2024.

Motto: "Every Step in Education is a Journey Towards Enlightenment"

Buku *Bunga Rampai: Etika dan Hukum dalam Rekam Medis* merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai isu penting terkait rekam medis dari sudut pandang etika dan hukum. Rekam medis bukan hanya alat dokumentasi, melainkan juga menyimpan tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan dan hak pasien, serta dalam menjamin integritas profesi tenaga kesehatan.

Buku ini terdiri dari empat bagian utama. Pertama, pembahasan mengenai *Etika dalam Penyimpanan dan Penggunaan Rekam Medis* yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dalam menangani informasi pasien. Kedua, *Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis*, yang mengulas konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika rekam medis disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang. Ketiga, *Hak Akses Pasien terhadap Rekam Medis*, yang membahas hak pasien untuk mengetahui, meminta, dan mengakses informasi medis mereka secara terbuka. Keempat, *Tantangan Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis*, yang membahas dinamika dan dilema baru yang muncul akibat penggunaan sistem elektronik dan teknologi informasi dalam pengelolaan rekam medis.

Buku Bunga Rampai: Etika dan Hukum dalam Rekam Medis merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai isu penting terkait rekam medis dari sudut pandang etika dan hukum. Rekam medis bukan hanya alat dokumentasi, melainkan juga menyimpan tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan dan hak pasien, serta dalam menjamin integritas profesi tenaga kesehatan.

Buku ini terdiri dari empat bagian utama. Pertama, pembahasan mengenai Etika dalam Penyimpanan dan Penggunaan Rekam Medis yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dalam menangani informasi pasien. Kedua, Implikasi Hukum Akibat Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis, yang mengulas konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika rekam medis disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang. Ketiga, Hak Akses Pasien terhadap Rekam Medis, yang membahas hak pasien untuk mengetahui, meminta, dan mengakses informasi medis mereka secara terbuka. Keempat, Tantangan Etika dalam Era Digitalisasi Rekam Medis, yang membahas dinamika dan dilema baru yang muncul akibat penggunaan sistem elektronik dan teknologi informasi dalam pengelolaan rekam medis.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

